

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD SANTA MARIA

FACULTAD DE FARMACIA

PASANTIAS A OFICINA DE FARMACIA I

La Quiebra de la Cadena de Custodia en la
Reincorporación de Medicamentos Devueltos:
Un Riesgo Silencioso para la Seguridad del
Paciente

ALUMNOS:

Daniel León C.I. 29.609.682

Luis Mirabal C.I. 20.955.000

Beatriz Sabe C.I. 30.225.937

PROFESOR:

Gianfranco Giuttari

Caracas, 17 de junio de 2026

Resumen

El presente artículo aborda una problemática operativa y bioética de alta frecuencia en la oficina de farmacia comunitaria: la aceptación y posterior reincorporación al inventario de venta de medicamentos devueltos por los usuarios. Aunque comercialmente se gestiona como una política de servicio al cliente, desde la perspectiva sanitaria representa un nudo crítico insostenible. Una vez que el producto abandona el establecimiento, cesa el control sobre sus condiciones de almacenamiento (temperatura, luz y humedad), comprometiendo su estabilidad y pureza. El estudio analiza este fenómeno bajo el marco legal venezolano y propone directrices rigurosas de control.

Introducción

La misión fundamental de la oficina de farmacia comunitaria es garantizar que cada fármaco dispensado mantenga intactas las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas certificadas por el fabricante. Durante el periodo de pasantías profesionales en la cadena Farmatodo, se evidenció una gestión óptima en la preservación de los productos dentro de las instalaciones. Sin embargo, el dinamismo comercial introduce dinámicas que entran en conflicto directo con los principios de la farmacovigilancia y el aseguramiento de la calidad. El caso más evidente y crítico es el proceso de devolución de medicamentos por parte del consumidor, un hábito cotidiano que esconde un peligro latente para la salud pública cuando dicho producto se direcciona nuevamente hacia la venta al público

Planteamiento de la Problemática

El problema radica en la pérdida absoluta de la trazabilidad ambiental y de seguridad de un medicamento una vez que traspasa los límites físicos de la farmacia, y el riesgo sanitario que implica su posterior reventa a un segundo usuario. El flujo de este nudo crítico se origina de forma simple en el mostrador: un paciente adquiere un producto, se retira y, horas o días después, regresa solicitando un cambio o reembolso alegando un error en la compra o modificación de la terapia médica. La complicación científica y operativa se fundamenta en: Incertidumbre de almacenamiento externo: Durante el tiempo que el medicamento estuvo fuera de la farmacia, el profesional desconoce por completo las condiciones microclimáticas a las que fue expuesto. El producto pudo haber sufrido estrés térmico extremo (por ejemplo, dentro de un vehículo bajo el sol), exposición a humedad excesiva en baños, o radiación solar directa. Estas condiciones aceleran la degradación del principio activo o la formación de productos de degradación tóxicos, sin que el empaque exterior muestre daños visibles. Riesgo de contaminación o adulteración: No existen métodos de control en el mostrador que permitan al farmacéutico verificar si el producto sufrió micro-perforaciones, si se alteró el conteo interno de los blísteres o si fue expuesto a agentes contaminantes biológicos o químicos en el hogar del primer comprador. El peligro de la

"Reventa Ciega": Al aceptar la devolución basándose únicamente en la estética de la caja, el fármaco se ubica nuevamente en el anaquel. El siguiente usuario que lo adquiera recibirá un producto cuya eficacia legítima ha sido vulnerada, lo que puede traducirse en fallos terapéuticos graves (como crisis hipertensivas o ineficacia antibiótica).

Justificación de la Problemática

El abordaje y análisis de la quiebra de la cadena de custodia en la devolución de medicamentos se justifica por la necesidad imperativa de salvaguardar la salud pública y garantizar la seguridad del paciente. Aunque las devoluciones suelen ser vistas como un simple trámite de servicio al cliente, esta práctica representa un riesgo silencioso que debe ser erradicado de las oficinas de farmacia por las siguientes razones fundamentales:

- **Justificación Clínica y Sanitaria (Protección al Paciente):**
El propósito fundamental de la farmacia es asegurar que todo fármaco mantenga sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas intactas. Abordar este problema se justifica porque previene el peligro de la "reventa ciega". Al evitar que medicamentos devueltos regresen al anaquel, se protege al siguiente usuario de recibir un tratamiento ineficaz o tóxico, lo cual previene fallos

terapéuticos graves, como ineficacia antibiótica o crisis hipertensivas derivadas de productos degradados. Esto se alinea directamente con el objetivo de aplicar los conocimientos para una correcta farmacovigilancia.

- **Justificación Legal y Profesional (Blindaje del Farmacéutico):** Desde el punto de vista legal, la investigación de este nudo crítico es indispensable para proteger la licencia y la libertad del farmacéutico regente. La reincorporación de productos devueltos entra en conflicto directo con el Artículo 17 y el Artículo 19 de la Ley de Ejercicio de la Farmacia en Venezuela, así como con las directrices del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). Por lo tanto, establecer protocolos estrictos justifica la protección legal del regente frente a responsabilidades penales y civiles, ya que impide que este avale la calidad de un medicamento cuya conservación es técnicamente indemostrable.
- **Justificación Ética y Operativa (Prevalencia de la Ciencia sobre el Comercio):** Esta problemática justifica una reestructuración en la jerarquía de valores dentro del establecimiento comercial. Demuestra de manera concluyente que los criterios comerciales de atención al consumidor nunca deben prevalecer sobre la seguridad sanitaria. Sirve para concientizar a las gerencias de que las excepciones comerciales deben manejarse

estrictamente como mermas o desechos técnicos, asumiendo una pérdida económica justificada con el fin de honrar el compromiso ético de proteger la vida de la comunidad.

Sustentación Legal y Marco Regulatorio Venezolano

Esta práctica habitual del comercio colisiona de manera estricta con el marco jurídico sanitario de Venezuela:

A. Ley de Ejercicio de la Farmacia

- Artículo 17: Dictamina que el farmacéutico regente es el responsable de la pureza y buena conservación de los productos de la farmacia. Al reintroducir un medicamento que estuvo fuera de su custodia, el regente está avalando la calidad de un producto cuya conservación es técnicamente indemostrable, infringiendo su responsabilidad legal.
- Artículo 19: Obliga a despachar los medicamentos garantizando su eficacia legítima. La reventa de un producto que ha sufrido alteraciones térmicas invisibles vulnera este artículo, pues la farmacia ya no puede certificar científicamente dicha eficacia.

B. Regulaciones del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

- Las Buenas Prácticas de Dispensación y Almacenamiento emitidas por el SACS son sumamente claras: un medicamento que ha salido del circuito farmacéutico pierde automáticamente su condición de apto para la venta. Las normativas sanitarias prohíben la reincorporación al inventario de productos devueltos por pacientes precisamente por la imposibilidad de garantizar que no hayan sido objeto de almacenamiento inadecuado.

Propuestas de Solución Profesionales y Prácticas

Para corregir esta vulnerabilidad institucional y legal sin que afecte la relación de confianza con el usuario, se proponen las siguientes medidas de control: Política de "No Devolución Sanitariamente Obligatoria": Establecer un lineamiento institucional estricto y visible en los mostradores y facturas que estipule que, por regulaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y resguardo de la seguridad de los pacientes, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos una vez hayan salido de la farmacia. Esto

traslada la responsabilidad al ámbito legal de la salud y protege al personal de mostrador.

Protocolo de Destrucción/Merma Técnica para Excepciones Comerciales: En aquellos casos extremos donde la farmacia deba aceptar la devolución por razones comerciales de peso (ej. un error del propio personal al facturar), el medicamento no debe regresar jamás al anaquel de venta. Se debe protocolizar su ingreso directo a una caja de "Merma o Desecho Técnico" para su posterior destrucción o devolución al laboratorio como producto no apto, asumiendo el costo como una pérdida operativa y nunca como un riesgo para el siguiente cliente.

Conclusión

El análisis de este problema cotidiano demuestra que los criterios comerciales de atención al cliente nunca deben prevalecer sobre la seguridad sanitaria y los principios científicos de la farmacia. La cadena de custodia de un medicamento es un contrato inquebrantable de calidad; si se rompe, el producto pierde su valor terapéutico confiable. Implementar políticas estrictas de no reventa de devoluciones es una acción indispensable para dar cumplimiento a la Ley de Ejercicio de la Farmacia, blindar la responsabilidad penal y civil del farmacéutico regente y, por encima de todo, honrar el compromiso ético de proteger la vida de la comunidad.